

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準 The Nursing Care of Cancer Treatment				
編號	A31000-Q02-W-L08	制定者	N17 陳瑩健	公布日期	103 年 05 月 21 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 2.1 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

讓護理人員了解癌症治療之相關照護。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

癌症治療之簡介、臨床應用、癌症治療藥物的前中後評估及照護重點、常見副作用及其護理：

（一）簡介

癌症治療是指使用化學方法合成的藥物來治療疾病，通常是指針對惡性腫瘤的治療。癌症治療的藥物主要是藉著血液循環至癌細胞處，抑制它們的生長，使其皺縮，甚至消失，而達到治療的目的。癌症治療可以單獨使用一種藥物或多種藥物合併治療，藥物的選擇是由醫師依據每位病人疾病的種類、程度、腫瘤位置及身體狀況等因素來決定。

（二）癌症治療給藥途徑

1. 口服給藥。
2. 肌肉或皮下注射。
3. 靜脈或動脈注射。
4. 膀胱內給藥。
5. 肋膜腔內或腹腔內注射。
6. 局部塗抹。

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	2/10

(三) 癌症治療臨床應用

依癌症治療的目的不同可分為前導性、輔助性、拯救性、緩和性、主要性與同步性等藥物治療。

癌症治療種類	目的	治療方向
前導性藥物治療	1. 減少腫瘤體積 2. 減少遠處轉移 3. 評估化療反應	在手術或放射線治療前使用。有腫瘤的狀況，可評估臨床性和病理性反應率、無病存活期和中位存活期。
輔助性藥物治療	1. 減少局部復發 2. 減少遠處轉移	在手術或放射線治療後使用。無腫瘤的狀況，不能評估化療反應率，但可評估無病存活期和中位存活期。
拯救性藥物治療	1. 第一線治療失敗時之治療 2. 復發後治療	雖然復發，但仍朝治癒方向進行治療。
緩和性藥物治療	緩解症狀	使用於無法治癒的局部晚期、復發或轉移性疾病。
主要性藥物治療	以化學治療做為主要根治性治療	使用於血液科癌症：白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤；生殖細胞癌及小細胞肺癌。
同步性藥物治療	加強局部控制	與放射線療法同步。依放射線療法的目的，可做為前導或輔助性。

(四) 癌症治療藥物的前中後評估及照護重點

1. 癌症治療前

- (1)評估上次癌症治療後有產生哪些副作用。
- (2)生理評估：Hb $\geq$ 10g/dl，WBC $\geq$ 3000ul，ANC $\geq$ 1500ul，Platelet $\geq$ 10 萬 ul。
- (3)測量身高與體重。
- (4)幫病人建立管路，如：靜脈留置針、PORT-A 或 PICC。
- (5)確認管路是否通暢及有無回血。
- (6)衛教血液管路照護，如：避免提超過 5 公斤重物、運動時避免手臂大範圍旋轉活動（如游泳、網球、高爾夫球）、注射癌症治療藥物時勿拉扯到管路等。
- (7)確認病人癌症治療同意書填寫的完整性。
- (8)說明癌症治療進行過程，包括前置藥物及癌症治療藥物給予的順序、滴注時間。

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	3/10

(9)提供癌症治療藥物副作用及其相關照護衛教單張。

(10)核對癌症治療藥物點滴瓶之標示：癌症治療藥物點滴專用標籤上須註明病人姓名、藥物名稱、劑量、點滴名稱和點滴劑量及調配者，並需經雙重核對才可以給藥。

2. 癌症治療中

(1)輸注癌症治療藥物期間，注意管路通暢性。

(2)監測有無外滲症狀。

(3)輸注癌症治療藥物期間，監測病人有無不適主訴及副作用或過敏症狀發生。

(4)若有任何異狀，應先立即停止輸注，並告知醫生。

3. 癌症治療後

(1)監測病人後續有無不適症狀及副作用發生。

(2)觀察病人體力狀況。

(3)觀察進食狀況是否改變。

(五) 癌症治療藥物的常見副作用及護理

癌細胞是生長分裂速度較快的細胞，而抗癌藥物就是針對這個特性專門設計來殺死快速生長的細胞。但是體內某些正常的組織細胞在平常的狀況下生長分裂的速度也很快，因此癌症治療藥物也會影響到這些細胞的生理功能，進而造成副作用的產生。最可能被影響到的細胞包括有骨髓造血細胞、消化道的表皮黏膜細胞、生殖系統的細胞以及毛囊細胞；甚至可能傷害到心臟、腎臟、膀胱、肺臟及神經系統等，大部分受影響的正常組織在癌症治療藥物結束後都會很快的復原。臨床上照護首次癌症治療藥物之病人時，需主動提供病人口腔黏膜炎照護、噁心嘔吐及白血球低下照護等三項常見副作用護理指導，後續再依病人狀況給予加強衛教。以下將就癌症治療藥物常見的副作用及護理做介紹：

常見副作用	護理指導	評估重點
頭髮脫落	1. 頭髮掉落的程度，主要是與使用藥物有關，所以嚴重的掉髮可能在開始治療數天至數星期即會發生。大量的落髮可能會造成禿頭，不過此副作用是短暫的，等到治療計劃完全結束後約1-2個月，	定期及視需要評估病人身體心像感受與看法。

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	4/10

常見副作用	護理指導	評估重點
	頭髮會慢慢長出來。 2. 衛教使用假髮、頭巾及帽子等保護頭皮，以維持良好的自我身體心像。 3. 儘量少洗頭且梳頭輕柔及避免染燙，並儘量選擇使用梳牙較疏之梳子梳頭，以避免掉髮。 4. 鼓勵說出禿髮對身體心像之影響。	
腹瀉	1. 嘗試清淡流質飲食，讓腸胃道有時間休息。 2. 注意水分及電解質的補充，在身體狀況允許的情況下選擇含鉀高及富含水溶性維他命的食物，如：蔬菜汁、葡萄汁、橘子汁、蘋果、香蕉及馬鈴薯等。 3. 為了避免腹瀉加重，此期間應避免攝取纖維質高及產氣的食物，如：牛奶、蔬菜、堅果類、豆類或裸麥麵包等。改進食低纖維飲食，如：白麵條、白麵包、米湯、米漿、蘇打餅乾、去皮雞肉及蛋等。 4. 避免辛辣刺激、炸物及油膩食物。 5. 維持肛門及週邊肌膚清潔、乾燥及通風，若有破皮或紅臀疼痛等症狀，請告知醫護人員，以提供合宜護理方式，請勿自行敷藥處理以免造成感染。	
口咽黏膜炎	1. 攝取清淡多汁的飲食，並避免乾燥尖硬、刺激及過熱的食物。 2. 選擇溫和不刺激之高蛋白、高熱量且為軟質易咀嚼食物，如：麵條、蒸蛋、布丁；避免太酸、辣、冷、熱及硬之食物如：芭樂、甘蔗等。 3. 若出現口腔疼痛症狀，應告知醫師開立止痛藥及漱口劑減輕疼痛，衛教口含冰塊及冰水也可減輕疼痛。 4. 維持良好口腔衛生，飲食後以清水漱口，並使用牙線及軟毛牙刷。 5. 必要時可請醫師開立口腔藥膏，以促進口腔黏膜之癒合。 6. 若有吞嚥困難，需請醫師評估是否使用管灌飲食，並需避免嗆到，以免導致吸入性肺炎。	每日或必要時評估一天水分攝取量及進食量。
噁心、嘔吐	1. 穿著寬鬆的衣物。 2. 感到噁心時多做深呼吸並放慢呼吸節奏，維持舒適及空氣流通的環境。 3. 鼓勵少量多餐，細嚼慢嚥可消化的更好。 4. 用餐前可以檸檬水漱口，噁心時可嘗試口含一些冰塊或薄荷片。 5. 採低渣、軟質及高蛋白易消化的食物，如：蛋、乳酪、果凍，並避免油炸及核果類之食物。 6. 兩餐之間可以用冰涼的飲料幫助消化。 7. 維持水分及電解質平衡。	1. QD&PRN 評估噁心及嘔吐程度。 2. QD&PRN 評估液體水份攝取量與飲食狀況。

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	5/10

常見副作用	護理指導	評估重點
	8. 治療前後兩小時內勿進食，稍作休息後再進食，必要時請醫師開立止吐劑來預防嘔吐。	
骨髓抑制	1. 每週定期抽血檢查。 2. 若白血球低於 $3000/mm^3$ 則採保護性隔離。 3. 避免皮膚黏膜受傷，而造成發炎。 4. 維持安全環境，以減少不必要之碰撞或跌倒。 5. 於刷牙時使用軟毛牙刷避免牙齦出血。 6. 避免造成傷口，若出現出血應壓迫至出血停止才可放開，避免服用會干擾血小板功能之藥物如：aspirin類藥物。	QD&PRN 評估病人出血症狀。
貧血	1. 定期追蹤及評估貧血徵象與症狀，如：頭暈、頭痛、疲倦、結膜蒼白及怕冷等。 2. 衛教病人攝取高蛋白、高鐵、礦物質、維生素B12及葉酸之飲食，以利紅血球生成。 3. 姿位改變時宜注意安全，下床時動作宜緩慢，且有他人協助。	QD&PRN 評估活動能力及暈眩狀況。
食慾不振	1. 少量多餐，三餐中間可準備高熱量、高蛋白質點心及飲料。 2. 提供重質不重量的飲食，意即吃得好（儘量能均衡攝取四大類飲食），也許不會吃很多，精選營養成分高的食物來達到營養需求。 3. 經常變化菜色，嘗試不同食譜及烹調方式，善用色、香、味的改變來提高食慾。 4. 因味蕾發生變化，有些病人會覺得肉類變苦，所以在處理肉類料理時可以少許果汁及酒浸泡。 5. 在愉悅環境下用餐，飯前可吃一些開胃的食物及飲料（如洛神茶、楊桃汁、酸梅汁等）來提高食慾。 6. 依醫囑補充維生素及礦物質。	
感覺神經異常	1. 感覺遲鈍時，注意不要拿尖銳的、太燙或太重的物品。 2. 當平衡感或肌肉力量受影響，在活動時應請他人協助。 3. 應穿著止滑鞋，浴室地板要鋪防滑墊以防止滑倒。 4. 可經常按摩及伸展肢體末梢。	
皮膚紅疹/ 脫屑	1. 可塗抹乳霜保持滋潤。 2. 化療期間若有紅疹、皮膚發癢或潰瘍須告知醫護人員。 3. 青春痘出現時要盡量保持臉部清潔。 4. 使用防曬乳或物理性防曬方式（帽子、外套、口罩等）。 5. 做家事時戴手套來保護皮膚及指甲。	
手足症候群	1. 依藥物性質在給藥當天及三天內給予冰敷。 2. 擦拭綿羊油或含維生素A.D.E.的乳霜保護四肢。 3. 服用維生素B6每天200mg。	若出現二、三級症狀，須先停藥。

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	6/10

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

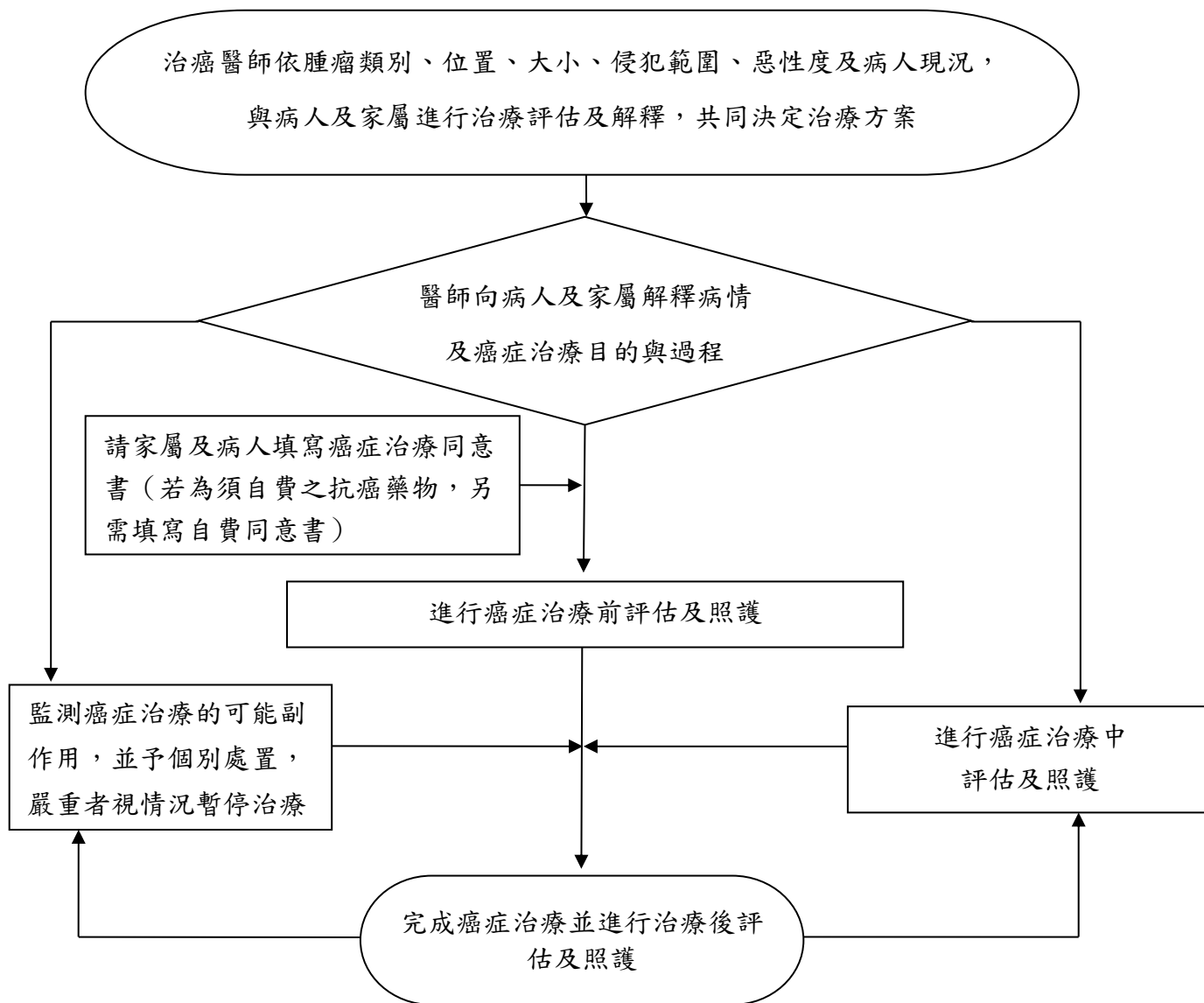
四、使用表單

(略)

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	7/10

五、流程圖

(一) 癌症治療及照護流程



主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	8/10

六、參考資料

- (一) 周繡玲、楊克平、簡淑慧、胡文郁、許麗珠、趙子傑、鄭春秋、陳敏銓、陳瑞儀、陳秋慧、顧乃平、黃采薇(2017)•癌症護理學（五版）•台北：華杏。
- (二) 楊家豪、楊家豪(2024)•頭頸癌常見化療藥物及副作用之照護•彰化護理，31(3)：6-12。

七、附件

(略)

主題名稱	癌症治療護理照護作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L08	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
103.05.21	1.0	新制定。	103 年 05 月 21 日護理部照護標準委員會通過；103 年 05 月 21 日公布。
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.01	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.12.06	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.19	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.01.21	1.1	1. 第三項第一、三、五目文字修訂。 2. 第三項第二目說明內容修訂。 3. 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過；109 年 01 月 08 日護理長會議通過；109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.12.03	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.06	2.0	1. 主題名稱及說明內文：化學治療全改為癌症治療。 2. 第三項第二目說明內容修訂。 3. 第三項第四目說明內容修訂。 4. 第三項第五目說明內容修訂。	110 年 04 月 01 日照護標準組會議通過；110 年 05 月 12 日護理長會議通過；110 年 07 月 06 日督導會議通過公布。
111.12.08	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

